BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Hemşirelik Süreci Çalışma Notu

Veri Toplama · Hemşirelik Tanısı · Planlama · Uygulama · Değerlendirme ve Yeniden Planlama

FR.185 Hemşirelik Sürecine Göre Değerlendirme (40 puan) için: her basamak nasıl yapılır ve nasıl yazılır, en sık hatalar ve tam örnek bakım planları.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – Hemşirelik Süreci Çalışma Notu

1. Hemşirelik süreci nedir?

2. VERİ TOPLAMA

- 2.1 Veri türleri
- 2.2 Veri kaynakları ("tüm kaynaklar")
- 2.3 Veri toplama yöntemleri
- 2.4 "Bütüncül" veri toplama – Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri
- 2.5 Aile ile çalışırken kullanılan veri toplama araçları
- 2.6 Verilerin doğrulanması ve düzenlenmesi

3. HEMŞİRELİK TANISI

- 3.1 Hemşirelik tanısı nedir, tıbbi tanıdan farkı ne?
- 3.2 NANDA-I tanısının bileşenleri
- 3.3 Tanı türleri ve yazım biçimleri
- 3.4 Etiyolojiyi (ilişkili faktörleri) doğru yazmak
- 3.5 Tanımlayıcı özellikleri doğru yazmak
- 3.6 Tanıları önceliklendirmek ve "yeterli sayıda" tanı
- 3.7 Halk sağlığında sık kullanılan tanılar – hangi durumda?

4. PLANLAMA

- 4.1 Amaç
- 4.2 Sonuç kriterleri
- 4.3 Girişimler

5. UYGULAMA

6. DEĞERLENDİRME VE YENİDEN PLANLAMA

- 6.1 Sonuç kriterlerine göre değerlendirme
- 6.2 Neden ulaşılamadı? – Yeniden değerlendirme soruları
- 6.3 Yeniden planlama kararları

7. TAM ÖRNEK BAKIM PLANLARI

- 7.1 Örnek A – ASM: Hipertansiyonu olan erişkin
- 7.2 Örnek B – Lohusa izlemi: Etkisiz emzirme
- 7.3 Örnek C – Ev ziyareti: Yaşlıda düşme riski
- 7.4 Örnek D – Sağlığı geliştirme tanısı: Gebe

8. BAKIM PLANI YAZARKEN KONTROL LİSTESİ

9. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – Hemşirelik Süreci Çalışma Notu

Bu not, FR.185 İME Değerlendirme Formu'ndaki **"Hemşirelik Sürecine Göre Değerlendirme (40 puan)"** bölümüne hazırlanman için yazıldı. Formun neredeyse yarısı bu bölümden oluşur ve her basamak ayrı ayrı puanlanır:

- **Veri toplama ve tanılama (16 puan):** Tüm veri kaynaklarını kullanarak sağlık gereksinimlerine uygun, bütüncül ve sistematik veri toplama (4); objektif ve subjektif veriler doğrultusunda öncelik sırasına göre yeterli sayıda uygun hemşirelik tanısı koyabilme (4); tanı etiyolojisini/ilişkili faktörleri belirleyebilme (4); tanımlayıcı özellikleri belirleyebilme (4).
- **Planlama (12 puan):** Amaçları belirleyebilme (4); sonuç kriterlerini belirleyebilme (4); bireye özgü bakım girişimlerini belirleyebilme (4).
- **Uygulama (4 puan):** Girişimleri öncelik sırasına göre uygulayabilme (4).
- **Değerlendirme (8 puan):** Sonuç kriterlerine göre değerlendirebilme (4); değerlendirme sonucuna göre hemşirelik sürecini tekrar planlayabilme (4).

Ayrıca FR.184 beceri 8'de "**bireyden yeterli sağlık öyküsünü alabilme ve bireye özgü sağlık eğitimini planlayabilme**" isteniyor; bu da hemşirelik sürecinin veri toplama ve planlama basamaklarıdır.

Bu bölümde puan kaybı genellikle bilgisizlikten değil, **yazım hatalarından** olur: etiyolojinin boş bırakılması, tıbbi tanının hemşirelik tanısı gibi yazılması, ölçülemeyen sonuç kriterleri, kalıp girişimler, değerlendirmeden sonra yeniden planlama yapılmaması. Bu not her basamağı, nasıl yazılacağını ve en sık yapılan hataları örneklerle anlatır.

---

1. Hemşirelik süreci nedir?

Hemşirelik süreci, hemşirenin bireyin, ailenin ya da toplumun sağlık gereksinimlerini **sistemli ve bilimsel bir yolla** belirleyip karşıladığı **problem çözme yöntemidir**. Beş basamağı vardır:

1. **Veri toplama (tanılama/değerlendirme):** Bireyle ilgili bilgilerin toplanması, doğrulanması ve düzenlenmesi.
2. **Hemşirelik tanısı:** Toplanan verilerin analiz edilip bireyin sağlık sorunlarının, risklerinin ve güçlü yönlerinin adlandırılması.
3. **Planlama:** Her tanı için amaç, sonuç kriterleri ve girişimlerin belirlenmesi; tanıların önceliklendirilmesi.
4. **Uygulama:** Planlanan girişimlerin hayata geçirilmesi ve kaydedilmesi.
5. **Değerlendirme:** Bireyin sonuç kriterlerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ve gerekirse planın yeniden düzenlenmesi.

Bu basamaklar **döngüseldir**: değerlendirme yeni verilere, yeni veriler yeni tanılara ve planlara yol açar. Halk sağlığında süreç bir **bireye** (ASM'ye gelen hasta, gebe, lohusa, yaşlı), bir **aileye** (ev ziyareti) ya da bir **topluma** (okul, huzurevi, işyeri) uygulanabilir. Bu notta ağırlık bireysel bakım planındadır; toplum düzeyi ayrı bir notta anlatılır.

Halk sağlığında hemşirelik sürecinin hastane bakımından farkı şudur: Burada çoğunlukla **sağlıklı ya da kronik hastalığı olan, evinde yaşayan** bireylerle çalışırsın. Bu yüzden tanılar daha çok **sağlığı sürdürme, risk, bilgi, davranış, aile ve çevre** ile ilgilidir; girişimler de çoğunlukla **eğitim, danışmanlık, izlem ve yönlendirme** şeklindedir.

---

2. VERİ TOPLAMA

Formdaki ifade: "**Tüm veri toplama kaynaklarını kullanarak sağlık gereksinimlerine uygun, bütüncül ve sistematik veri toplama.**" Bu cümlenin üç anahtar sözcüğü vardır: **tüm kaynaklar**, **bütüncül**, **sistematik**.

2.1 Veri türleri

Subjektif veri, bireyin kendi ifadeleridir: duyguları, düşünceleri, algıları, yakınmaları. Bu veriler başkası tarafından ölçülemez; ancak bireyin anlatımıyla öğrenilir. Bakım planında **tırnak içinde, bireyin kendi sözleriyle** yazılmalıdır. Örnekler: "Tuzsuz yemek boğazımdan geçmiyor." / "Kendimi iyi hissedince ilacımı içmiyorum." / "Bebeğim doymuyor, sütüm yetmiyor." / "Gece tuvalete kalkarken başım dönüyor."

Objektif veri, hemşirenin gözlem, ölçüm, muayene ya da test sonuçlarıyla elde ettiği verilerdir. Başkası da aynı yöntemi kullansa aynı sonuca ulaşır. Örnekler: Kan basıncı 156/96 mmHg; BKİ 31,2; bel çevresi 104 cm; bebeğin ağırlığı doğum ağırlığının %8 altında; meme başlarında çatlak; Kalk ve Yürü testi 16 saniye; HbA1c %8,4; evde kaygan halılar var.

İyi bir bakım planında her tanı **hem subjektif hem objektif veriyle** desteklenir. Yalnızca subjektif veriye dayanan tanı zayıf kalır.

2.2 Veri kaynakları ("tüm kaynaklar")

- **Birincil kaynak – bireyin kendisi:** En değerli kaynaktır. Bilinci yerinde ve iletişim kurabilen her bireyden bilgi önce kendisinden alınır.
- **İkincil kaynaklar:**
  - **Aile üyeleri ve bakım verenler** (çocuklar, yaşlılar, iletişim kuramayan bireyler için özellikle önemli)
  - **Kayıtlar:** ASM bilgi sistemi, e-Nabız, izlem kartları, aşı kartı, gebe izlem kartı, tahlil sonuçları, epikriz, ilaç listesi
  - **Sağlık ekibi:** Aile hekimi, aile sağlığı elemanı, diyetisyen, diğer çalışanlar
  - **Literatür ve rehberler:** Normal değerleri ve bireyin durumunu karşılaştırmak için
  - **Ev ve çevre gözlemi:** Ev ziyaretinde yaşam koşulları

Bakım planında veri kaynaklarını belirtmen ("Veriler bireyden, eşinden, ASM kayıtlarından ve fizik muayeneden elde edildi") formdaki "tüm kaynakları kullanma" ölçütünü karşıladığını gösterir.

2.3 Veri toplama yöntemleri

Görüşme (öykü alma): Planlı, amaca yönelik bir konuşmadır.

- **Açık uçlu sorular** bireyin kendini anlatmasını sağlar: "Hastalığınızla ilgili neler düşünüyorsunuz?", "Bir gününüzü anlatır mısınız?"
- **Kapalı uçlu sorular** belirli bir bilgiyi netleştirir: "İlacınızı bugün aldınız mı?", "Kaç yaşındasınız?"
- Görüşme genelden özele, az hassas konulardan hassas konulara doğru ilerler.
- Bireyin söylediklerini **yeniden ifade etme** ("Yani akşamları ilacınızı unutuyorsunuz, öyle mi?") ve **açıklığa kavuşturma** ("'Sık sık' derken günde kaç kez?") verinin doğruluğunu artırır.

Gözlem: Bireyin görünümü, davranışı, beden dili, ev ortamı, bebek ile annenin etkileşimi, emzirme, ilaç kullanma biçimi gözlenir. Gözlem, söylenenle yapılanın uyumunu kontrol etmeyi sağlar.

Fizik muayene: Dört temel teknik kullanılır: **inspeksiyon** (bakı), **palpasyon** (elle muayene), **perküsyon** (vurma) ve **oskültasyon** (dinleme). Halk sağlığında özellikle bakı ve palpasyon (ödem, fundus, meme, ayak), ölçümler ve dinleme (fetal kalp sesi) kullanılır.

Ölçümler: Kan basıncı, nabız, solunum, ateş, boy, kilo, BKİ, bel çevresi, baş çevresi, fundus yüksekliği, parmak ucu kan şekeri.

Ölçekler ve formlar: Bireyin durumunu sayısal olarak değerlendirir. Örnekler: Katz ve Lawton günlük yaşam aktiviteleri ölçekleri, Mini Mental Test, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, Braden bası yarası riski, Kalk ve Yürü testi, aile APGAR.

Kayıt incelemesi: Önceki izlemler, tahliller, ilaçlar.

2.4 "Bütüncül" veri toplama – Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri

"Bütüncül" demek, bireyi yalnızca hastalığıyla değil **fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve çevresel** tüm yönleriyle değerlendirmek demektir. "Sistematik" demek ise bunu **belirli bir model çerçevesinde, hiçbir alanı atlamadan** yapmaktır. Bireysel bakım planlarında en çok kullanılan çerçeve **Gordon'un 11 Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü**dür. Her örüntüde halk sağlığı bağlamında neleri soracağın aşağıda anlatılıyor.

1. Sağlığı algılama – sağlık yönetimi: Birey sağlığını nasıl tanımlıyor ve değerlendiriyor? Hastalığı hakkında ne biliyor, ne düşünüyor? Tedaviye uyumu nasıl (ilaç, diyet, kontroller)? Koruyucu sağlık davranışları: aşılar, kanser taramaları, düzenli kontroller, kendi kendine muayeneler. Sigara, alkol, madde kullanımı. Kaza ve güvenlik önlemleri. Sağlık hizmetine erişimi.

2. Beslenme – metabolik: Günlük besin ve sıvı tüketimi (24 saatlik besin tüketimini sormak iyi bir yöntemdir), öğün düzeni, tuz-şeker-yağ tüketimi, iştah, son dönemde kilo değişimi, boy-kilo-BKİ-bel çevresi, diş ve ağız sağlığı, yutma güçlüğü, cilt ve yara iyileşmesi, ateş. Bebekte emzirme ve ek gıda; gebede kilo alımı ve destekler.

3. Boşaltım: Dışkılama sıklığı ve özelliği, kabızlık, ishal, idrar sıklığı, idrar kaçırma, idrarda yanma, terleme. Bebekte ıslak bez sayısı.

4. Aktivite – egzersiz: Günlük aktiviteler, düzenli egzersiz (süre ve sıklık), oturarak geçen süre, ekran süresi, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık, yürüme ve denge, düşme öyküsü, solunum (nefes darlığı) ve dolaşım (çarpıntı, ödem) yakınmaları, boş zaman etkinlikleri.

5. Uyku – dinlenme: Günlük uyku süresi, uykuya dalma ve sürdürme güçlüğü, uyandığında dinlenmiş hissetme, gündüz uyuklama, uyku ilacı kullanımı.

6. Bilişsel – algısal: Görme, işitme, tat ve dokunma duyuları; gözlük ve işitme cihazı; ağrı (yeri, şiddeti, süresi); bellek, dikkat, karar verme, okuryazarlık ve **öğrenme biçimi** (eğitim planı için önemlidir).

7. Kendini algılama – benlik kavramı: Bireyin kendini nasıl gördüğü, beden imajı, özgüven, kaygı, korku, umutsuzluk, ruh hali.

8. Rol – ilişki: Aile yapısı, evde kimlerle yaşadığı, aile içi roller ve sorumluluklar (bakım verme, çocuk bakımı), aile ilişkileri, sosyal destek, iş ve meslek, ekonomik durum, sosyal izolasyon, şiddet.

9. Cinsellik – üreme: Kadında adet öyküsü, gebelik-doğum-düşük öyküsü, aile planlaması yöntemi, menopoz; cinsel sağlıkla ilgili kaygılar (uygun ortamda ve gerekli olduğunda).

10. Baş etme – stres toleransı: Son dönemdeki önemli yaşam değişiklikleri (kayıp, taşınma, iş kaybı, yeni bebek), stres kaynakları, stresle nasıl baş ettiği, destek aldığı kişiler.

11. Değer – inanç: Sağlık kararlarını etkileyen değerler, inançlar, dini uygulamalar (oruç, beslenme kuralları), kültürel uygulamalar (lohusalık gelenekleri, bebek bakımıyla ilgili inanışlar).

Bu örüntüleri kullanarak veri topladığında, hem formdaki "bütüncül ve sistematik" ölçütünü karşılarsın hem de tanıları kolayca belirlersin; çünkü NANDA-I tanıları da bu örüntülerle uyumlu alanlarda gruplanır.

2.5 Aile ile çalışırken kullanılan veri toplama araçları

Ev ziyareti ya da aile odaklı bakım planında bireysel verilere ek olarak aile değerlendirilir:

- **Aile tipi:** Çekirdek aile, geniş aile, tek ebeveynli aile, yeniden yapılanmış aile (boşanma/yeniden evlilik), çocuksuz çift, yalnız yaşayan birey.
- **Aile yaşam döngüsü (Duvall):** Ailenin hangi evrede olduğu ve o evrenin gelişimsel görevleri belirlenir. Evreler: (1) evli çift (çocuk yok), (2) çocuk doğurma (en büyük çocuk 0–30 ay), (3) okul öncesi çocuklu aile, (4) okul çağı çocuklu aile, (5) ergen çocuklu aile, (6) çocukların evden ayrılması, (7) orta yaşlı ebeveynler, (8) yaşlanan aile. Örneğin ikinci evredeki bir ailenin görevleri bebeğin bakımını öğrenmek, ebeveyn rollerine uyum sağlamak ve eşler arası ilişkiyi yeniden düzenlemektir; bu görevlerdeki güçlükler tanılara kaynak olur.
- **Genogram:** En az üç kuşağı gösteren aile ağacıdır; aile üyelerinin yaşları, hastalıkları, ölüm nedenleri ve ilişkileri gösterilir. Kalıtsal riskleri (diyabet, kalp hastalığı, kanser) görmek için yararlıdır.
- **Ekokart (eko-harita):** Ailenin dış sistemlerle (iş, okul, sağlık kurumu, akrabalar, komşular, dini kurumlar, sosyal hizmetler) ilişkisini çizgilerle gösteren şemadır; güçlü, zayıf ve stresli bağlantılar görülür.
- **Aile APGAR:** Ailenin işlevselliğini beş soruyla değerlendiren kısa bir araçtır: uyum (sorun olduğunda aileden yardım alabilme), paylaşım (kararların birlikte alınması), büyüme (yeni etkinliklere destek), sevgi (duyguların paylaşılması) ve birlikte zaman geçirme/çözüm.

2.6 Verilerin doğrulanması ve düzenlenmesi

Toplanan veriler **doğrulanmalıdır**: Bireyin "tansiyonum normal" demesi ölçümle; "düzenli ilaç içiyorum" demesi ilaç kutusundaki eksik tabletlerle ya da reçete tarihleriyle; "iyi besleniyorum" demesi 24 saatlik besin tüketimiyle karşılaştırılır.

Sonra veriler **kümelenir**: Birbiriyle ilişkili veriler bir araya getirilir ve bir örüntü oluşturup oluşturmadıklarına bakılır. Örneğin "Kendimi iyi hissedince ilacımı bırakıyorum" + "Tansiyon zaten herkeste var" + KB 156/96 + ilaç kutusunda fazla tablet → bu küme **"Etkisiz sağlık yönetimi"** tanısına işaret eder. "Yemeğe tadına bakmadan tuz ekliyorum" + her öğün turşu + "tuzsuz yemek yiyemem" → bu küme beslenme/tuz tüketimiyle ilgili bir tanıyı destekler.

Veri toplama bölümünün sonunda **bireyin güçlü yönlerini** de yazmak iyi bir uygulamadır (öğrenmeye istekli, eş desteği var, okuryazar, düzenli kontrollere geliyor). Güçlü yönler girişimleri planlarken kullanılır.

---

3. HEMŞİRELİK TANISI

Formda tanılama dört ayrı ölçütle puanlanır: **uygun ve yeterli sayıda tanı, öncelik sırası, etiyoloji (ilişkili faktörler) ve tanımlayıcı özellikler.** Yani tanının sadece adını yazmak 16 puanın en fazla dörtte birini getirir.

3.1 Hemşirelik tanısı nedir, tıbbi tanıdan farkı ne?

Hemşirelik tanısı, bireyin, ailenin ya da toplumun gerçek ya da olası sağlık sorunlarına ve yaşam süreçlerine verdiği **tepkiler** hakkında hemşirenin klinik yargısıdır. Hemşire bu tepkileri **bağımsız girişimleriyle** değiştirebilir ve sorumluluğu üstlenir.

Tıbbi tanı ise hastalığın kendisini tanımlar (hipertansiyon, tip 2 diyabet, mastit, preeklampsi) ve tedavisi hekimin sorumluluğundadır.

Örnek: Hekimin tanısı "hipertansiyon"dur. Hemşire ise bu bireyin hastalığa verdiği tepkiye bakar: Birey hastalığını ciddiye almıyor ve ilacını düzensiz kullanıyorsa hemşirelik tanısı "**Etkisiz sağlık yönetimi**"dir; tuz kısıtlaması hakkında bilgisi yoksa "**Bilgi eksikliği**"dir; hareketsizse "**Sedanter yaşam biçimi**"dir. Aynı tıbbi tanıya sahip iki bireyin hemşirelik tanıları tamamen farklı olabilir; bu yüzden bakım **bireye özgüdür**.

Hemşirenin hekimle birlikte izlediği ve tedavisi için hekim istemi gereken durumlar (örneğin hipoglisemi, kanama, preeklampsi gelişmesi) **işbirliği gerektiren sorunlar** olarak ayrıca düşünülür; bunlar hemşirelik tanısı biçiminde yazılmaz ama hemşire bunları **izler ve erken belirtilerini fark eder**.

3.2 NANDA-I tanısının bileşenleri

Hemşirelik tanıları uluslararası olarak **NANDA International (NANDA-I)** sınıflamasıyla standartlaştırılmıştır. Her tanının şu bileşenleri vardır:

- **Tanı etiketi:** Tanının adı (ör. "Etkisiz emzirme").
- **Tanım:** Tanının ne anlama geldiğinin açıklaması.
- **Tanımlayıcı özellikler:** Tanının var olduğunu gösteren **belirti ve bulgular** (subjektif ve objektif veriler). Problem odaklı ve sağlığı geliştirme tanılarında bulunur.
- **İlişkili faktörler:** Tanıya **neden olan ya da katkıda bulunan**, hemşirelik girişimleriyle **değiştirilebilen** etkenler (etiyoloji). Problem odaklı tanılarda bulunur.
- **Risk faktörleri:** Bireyi bir soruna karşı daha **duyarlı** hale getiren etkenler. Risk tanılarında bulunur.
- Yeni baskılarda ayrıca **risk altındaki popülasyonlar** (yaş, cinsiyet gibi değiştirilemeyen özellikler) ve **ilişkili durumlar** (tıbbi tanılar, ilaçlar gibi hemşirenin bağımsız olarak değiştiremeyeceği durumlar) da yer alır. Bunlar tanıyı anlamaya yardım eder ama **etiyoloji olarak yazılmaz**, çünkü hemşirelik girişimiyle değiştirilemezler.

> Tanı etiketlerinin Türkçe çevirileri NANDA-I baskıları arasında farklılık gösterebilir (örneğin "Bilgi eksikliği" yeni baskıda "Yetersiz sağlık bilgisi" olarak geçer). Bakım planında hangi baskıyı kullandığını belirtmen ve o baskının etiketini kullanman yeterlidir.

3.3 Tanı türleri ve yazım biçimleri

Problem odaklı (gerçek) tanı

Bireyde **şu anda var olan** bir soruna verilen tepkiyi tanımlar. Belirti ve bulgular vardır.

Yazım biçimi – PES: Problem (tanı etiketi) + **E**tiyoloji (ilişkili faktörler) + **S**emptom/belirti (tanımlayıcı özellikler). Türkçe yazımda kalıp şöyledir:

> **[Tanı etiketi]**; **[ilişkili faktörler] ile ilişkili**, **[tanımlayıcı özellikler] ile kendini gösteren.**

Örnekler:

- **Etkisiz sağlık yönetimi**; tedavi rejimine ilişkin bilgi eksikliği ve hastalığın ciddiyetini algılayamama ile ilişkili; antihipertansif ilacını kendini iyi hissettiğinde bırakması, "Tansiyon zaten herkeste var" demesi ve kan basıncının 156/96 mmHg olması ile kendini gösteren.
- **Etkisiz emzirme**; emzirme tekniğine ilişkin bilgi ve beceri eksikliği ile ilişkili; meme başlarında çatlak ve ağrı, bebeğin yalnızca meme başını kavraması, annenin mama takviyesi yapması ve "Sütüm yetmiyor" demesi ile kendini gösteren.
- **Sedanter yaşam biçimi**; fiziksel aktivitenin yararlarına ilişkin bilgi eksikliği ve zaman yönetiminde güçlük ile ilişkili; haftada 60 dakikadan az fiziksel aktivite yapması, günde 5 saat ekran karşısında oturması ve "Spor yapacak vaktim yok" demesi ile kendini gösteren.
- **Kabızlık**; yetersiz lif ve sıvı alımı ve demir preparatı kullanımı ile ilişkili; haftada 2 kez dışkılama, sert dışkı ve dışkılarken zorlanma ifadesi ile kendini gösteren.

Risk tanısı

Bireyde **henüz sorun yok** ama **sorunun gelişme olasılığı** yüksek. Belirti ve bulgu olmadığı için **tanımlayıcı özellik yazılmaz**; bunun yerine **risk faktörleri** yazılır.

Yazım biçimi:

> **[... riski]**; **[risk faktörleri] ile ilişkili** (ya da "risk faktörleri: ...").

Örnekler:

- **Düşme riski**; son 6 ayda düşme öyküsü, Kalk ve Yürü testinin 16 saniye olması, evde kaygan halılar ve yetersiz gece aydınlatması, 6 farklı ilaç kullanımı ve yalnız yaşama ile ilişkili.
- **Enfeksiyon riski**; doğum sonu epizyotomi yarası ve perine hijyenine ilişkin bilgi eksikliği ile ilişkili.
- **Kararsız kan şekeri düzeyi riski**; öğün atlama, insülin dozunu kendi kendine değiştirme ve kan şekeri izlemini düzensiz yapma ile ilişkili.
- **Yaralanma riski** (ev kazaları); 9 aylık bebeğin emeklemeye başlaması, evde ilaç ve deterjanların bebeğin ulaşabileceği yerde bulunması ve merdivende güvenlik kapısı olmaması ile ilişkili.

Sağlığı geliştirme tanısı

Bireyin **iyilik halini artırma isteğini ve hazır oluşunu** tanımlar. Bir sorun yoktur; birey daha iyiye gitmek ister. Etiyoloji yazılmaz; **tanımlayıcı özellikler** (isteğin ifadesi) yazılır.

Yazım biçimi:

> **[... geliştirmeye hazır oluş]**; **[istek ifadeleri] ile kendini gösteren.**

Örnekler:

- **Emzirmeyi geliştirmeye hazır oluş**; "Bebeğimi ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslemek istiyorum" ve "Doğru emzirip emzirmediğimi öğrenmek istiyorum" demesi ile kendini gösteren.
- **Sağlık yönetimini geliştirmeye hazır oluş**; "Kanser taramalarına düzenli gitmek istiyorum ama hangisini ne zaman yaptıracağımı bilmiyorum" demesi ile kendini gösteren.
- **Bilgiyi geliştirmeye hazır oluş** (gebelikte beslenme); "Gebelikte neler yememem gerektiğini öğrenmek istiyorum" demesi ve beslenme hakkında sorular sorması ile kendini gösteren.

Sendrom tanısı

Birlikte görülen bir tanı kümesini tek bir başlıkta toplar (ör. "Yaşlı kırılganlık sendromu"). Öğrenci bakım planlarında daha az kullanılır.

3.4 Etiyolojiyi (ilişkili faktörleri) doğru yazmak

FR.185 madde 13 doğrudan bunu puanlar. Kurallar:

1. **Etiyoloji, hemşirelik girişimiyle değiştirilebilir olmalıdır.** Bilgi eksikliği, yanlış inanış, beceri eksikliği, motivasyon eksikliği, kaynak yetersizliği, çevresel engeller, alışkanlıklar, aile desteğinin yetersizliği gibi etkenler uygundur.
2. **Tıbbi tanı etiyoloji olarak yazılmaz.** "Hipertansiyon ile ilişkili etkisiz sağlık yönetimi" yanlıştır; çünkü hemşire hipertansiyonu ortadan kaldıramaz. Doğrusu: "Tedavi rejimine ilişkin bilgi eksikliği ile ilişkili etkisiz sağlık yönetimi".
3. **Etiyoloji ile tanı aynı şey olmamalıdır.** "Emzirememe ile ilişkili etkisiz emzirme" bir döngüdür, bilgi vermez.
4. **Etiyoloji, girişimlere yön vermelidir.** Etiyoloji "bilgi eksikliği" ise girişim eğitimdir; "beceri eksikliği" ise uygulamalı öğretim; "unutma" ise hatırlatıcı yöntemler; "maddi olanaksızlık" ise kaynaklara yönlendirme. Yani etiyolojiyi doğru yazarsan girişimler kendiliğinden ortaya çıkar.
5. **Yasal ya da yargılayıcı ifadeler** kullanılmaz: "Annenin ilgisizliği ile ilişkili" yerine "Bebek bakımına ilişkin bilgi eksikliği ve aile desteğinin yetersizliği ile ilişkili".
6. **Hemşirenin gereksinimi** yazılmaz: "Eğitim verilmemesi ile ilişkili" yanlıştır; tanı bireyin durumunu anlatır.

3.5 Tanımlayıcı özellikleri doğru yazmak

FR.185 madde 14 bunu puanlar. Kurallar:

1. Tanımlayıcı özellikler, **senin topladığın verilerden** gelir; kitaptaki listeden kopyalanmaz. "Uyumsuzluk davranışı gösterme" gibi genel bir ifade yerine "ilacını son 1 haftada 3 gün almaması" gibi **somut veri** yazılır.
2. **Subjektif veriler tırnak içinde**, **objektif veriler ölçüm/gözlem olarak** yazılır.
3. Mümkünse **en az 2–3** tanımlayıcı özellik ve **hem subjektif hem objektif** veri kullanılır.
4. Tanımlayıcı özellikler, değerlendirme aşamasında karşılaştırma için kullanılacağından **ölçülebilir** olması değerlendirmeyi kolaylaştırır (KB değeri, dışkılama sayısı, kilo, puan).

3.6 Tanıları önceliklendirmek ve "yeterli sayıda" tanı

Formda "**öncelik sırasına göre yeterli sayıda uygun hemşirelik tanısı**" yazıyor. Bireysel bir bakım planında genellikle **3–5 tanı** yeterlidir; çok sayıda yüzeysel tanı yerine verilerle iyi desteklenmiş tanılar tercih edilir.

Önceliklendirmede kullanılan ölçütler:

- **Yaşamı tehdit eden durumlar önce gelir** (hava yolu, solunum, dolaşım). Halk sağlığında bu genellikle "hemen hekime bildir/sevk et" anlamına gelir; örneğin kan basıncı 190/115 ve baş ağrısı varsa diğer tüm tanılar bekler.

- **Maslow'un gereksinimler hiyerarşisi:** Önce fizyolojik gereksinimler (beslenme, boşaltım, uyku, ağrı), sonra güvenlik (düşme, enfeksiyon, yaralanma riski), sonra sevgi ve ait olma (aile ilişkileri, sosyal izolasyon), sonra saygınlık (benlik saygısı), en son kendini gerçekleştirme.
- **Gerçek sorunlar genellikle risk tanılarından önce gelir**; ancak ciddi bir risk (örneğin yüksek düşme riski olan yaşlı) gerçek ama hafif bir sorundan önce gelebilir.
- **Bireyin kendi önceliği:** Birey için en önemli olan sorunla başlamak işbirliğini artırır.
- **Diğer sorunları çözen sorun:** Örneğin bilgi eksikliği giderildiğinde ilaç uyumu ve diyet sorunu da çözülebilir.

Bakım planında tanıları önceliğe göre numaralandırıp **neden bu sırayı seçtiğini bir cümleyle açıklaman** hem 12. maddenin hem de 18. maddenin (öncelik sırasına göre uygulama) puanını destekler.

3.7 Halk sağlığında sık kullanılan tanılar – hangi durumda?

- **Etkisiz sağlık yönetimi:** Kronik hastalığı olan bireyin tedavi planını (ilaç, diyet, kontrol) günlük yaşamına uygulayamaması.
- **Sağlık yönetimini geliştirmeye hazır oluş:** Bireyin sağlığını daha iyi yönetmek istediğini ifade etmesi.
- **Etkisiz sağlığı sürdürme davranışları:** Koruyucu sağlık davranışlarının (tarama, aşı, kontrol) yapılmaması.
- **Riskli sağlık davranışı:** Sigara, alkol, sağlığı riske atan davranışlar ve bunları değiştirmede güçlük.
- **Bilgi eksikliği (yetersiz sağlık bilgisi):** Belirli bir konuda bilgisizlik ya da yanlış bilgi (yeni tanı almış diyabetli, ilk kez anne olan kadın). Genellikle başka bir tanının etiyolojisi olarak daha güçlüdür; tek başına kullanıldığında konu belirtilir ("bebek bakımına ilişkin bilgi eksikliği").
- **Sedanter yaşam biçimi, Obezite, Fazla kilo:** Hareketsizlik ve kilo sorunları.
- **Etkisiz emzirme, Kesintili emzirme, Emzirmeyi geliştirmeye hazır oluş:** Lohusa ve bebek izlemleri.
- **Ebeveynlik rolünde bozulma, Ebeveynliği geliştirmeye hazır oluş, Bağlanmada bozulma riski:** Anne-bebek ve aile izlemleri.
- **Bakım verici rol gerginliği:** Yaşlı ya da engelli bireye bakan aile üyesinin yükü.
- **Düşme riski, Yaralanma riski:** Yaşlı ve çocuk izlemleri, ev ziyaretleri.
- **Enfeksiyon riski:** Lohusalık, yara, bağışıklığı düşük bireyler, aşı eksikliği.
- **Kabızlık:** Gebelik, lohusalık, yaşlılık, demir kullanımı.
- **Uyku örüntüsünde bozulma, Yorgunluk:** Lohusalık, bakım verenler, vardiyalı çalışanlar.
- **Anksiyete:** Tarama sonucu bekleyen, ilk kez anne olan, tanı yeni konmuş bireyler.
- **Sosyal izolasyon:** Yalnız yaşayan yaşlılar.
- **Aile süreçlerinde bozulma:** Ailede kriz, hastalık, yeni bebek.
- **Toplum sağlığında yetersizlik, Etkisiz toplum baş etmesi:** Toplum ve kurum düzeyinde.

---

4. PLANLAMA

Planlama, formda üç ayrı ölçütle puanlanır: **amaç**, **sonuç kriterleri** ve **bireye özgü girişimler**.

4.1 Amaç

Amaç, tanının çözümüne yönelik **genel ve geniş** bir ifadedir. Bakımın sonunda bireyin ulaşması beklenen durumu anlatır. Kurallar:

- **Bireye aittir**, hemşireye değil. "Hastaya eğitim verilecek" bir amaç değil, bir girişimdir. Doğrusu: "Bireyin sağlık yönetimi etkili hale gelecek."
- Tanının **problem kısmına** yöneliktir: Tanı "Etkisiz emzirme" ise amaç "Anne bebeğini etkili biçimde emzirecek".
- Risk tanısında amaç sorunun **gelişmemesidir**: "Birey düşmeyecek" ya da "Bireyin düşme riski azalacak".
- Sağlığı geliştirme tanısında amaç isteğin **gerçekleşmesidir**: "Anne bebeğini ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle besleyecek."

4.2 Sonuç kriterleri

Sonuç kriterleri (beklenen sonuçlar), amaca ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren **ölçülebilir, gözlenebilir ve zaman sınırlı** davranış ya da durumlardır. Değerlendirme aşamasında bunlar tek tek kontrol edilecektir; bu yüzden **"oldu mu olmadı mı" diye kesin karar verilebilecek** biçimde yazılmalıdır.

SMART kuralı: Özgül (specific), ölçülebilir (measurable), ulaşılabilir (achievable), gerçekçi (realistic), zaman sınırlı (time-bound).

Bir sonuç kriterinin beş öğesi:

1. **Özne:** Kim? ("Birey", "Anne", "Ergen")
2. **Eylem fiili:** Ne yapacak? Ölçülebilir bir fiil: sayar, açıklar, ifade eder, gösterir, uygular, ölçer, yapar, ... düzeyinde olur.
3. **Ölçüt:** Ne ölçüde? ("en az 3 komplikasyonu", "8 basamağın en az 7'sini", "140/90 mmHg'nin altında")
4. **Koşul:** Hangi durumda? ("broşür yardımıyla", "maket üzerinde", "ilaç kutusunu göstererek")
5. **Zaman:** Ne zaman? ("eğitimin sonunda", "1 hafta içinde", "bir sonraki izlemde", "1 ay sonra")

Kullanılmaması gereken fiiller: bilir, öğrenir, anlar, kavrar, farkında olur, bilgilenir, uyum sağlar (tek başına), iyileşir (ölçütsüz). Bunlar gözlenemez ve ölçülemez.

Yanlış ve doğru örnekler:

- Yanlış: "Hasta tuz kısıtlamasını öğrenecek." → Doğru: "Birey eğitimin sonunda günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğini ifade edecek."
- Yanlış: "Hasta ilaçlarını düzenli kullanacak." → Doğru: "Birey iki hafta sonraki izlemde ilaç kutusunu göstererek 14 günün en az 13'ünde ilacını aldığını gösterecek."
- Yanlış: "Anne emzirme konusunda bilgilenecek." → Doğru: "Anne bugünkü görüşmede doğru kavramanın dört belirtisinin gözlendiği bir emzirme yapacak."
- Yanlış: "Tansiyonu düşecek." → Doğru: "Bireyin bir ay sonraki izlemde ölçülen ortalama kan basıncı 140/90 mmHg'nin altında olacak."

- Yanlış: "Yaşlı düşmeyecek." (amaç olarak doğru, kriter olarak eksik) → Doğru kriterler: "Birey görüşme sonunda evinde düşmeye neden olabilecek en az dört tehlikeyi ve önlemini ifade edecek." / "İki hafta sonraki ev ziyaretinde kaygan halılar kaldırılmış olacak." / "Birey üç ay boyunca düşme yaşamayacak."

Kısa ve uzun vadeli kriterler: Halk sağlığında bazı sonuçlar hemen (eğitim sonunda bilgi, geri gösterim), bazıları haftalar sonra (davranış değişikliği, kan basıncının düşmesi, kilo kaybı) ortaya çıkar. İyi bir planda **hem kısa hem uzun vadeli** kriterler bulunur. Bilgi → davranış → durum sıralaması izlenebilir: önce bilgiyi ifade etme, sonra davranışı uygulama, en sonda sağlık durumunda değişiklik.

Her tanı için genellikle **2–4 sonuç kriteri** yeterlidir.

4.3 Girişimler

Girişimler, bireyin sonuç kriterlerine ulaşması için **hemşirenin yapacakları**dır.

Girişim türleri:

- **Bağımsız girişimler:** Hemşirenin kendi bilgi ve yetkisiyle yaptığı girişimler: değerlendirme ve izlem (KB ölçümü, gözlem), sağlık eğitimi, danışmanlık, emzirme desteği, ev güvenliği değerlendirmesi, yönlendirme.
- **Bağımlı girişimler:** Hekim istemi gerektiren girişimler: ilaç ve aşı uygulama, tahlil isteme, tedavi değişikliği.
- **İşbirlikçi girişimler:** Diğer meslek üyeleriyle birlikte yapılan girişimler: diyetisyene, fizyoterapiste, sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa yönlendirme, okul rehber öğretmeniyle çalışma.

Girişimleri dört grupta düşünmek plan yazmayı kolaylaştırır:

1. **Değerlendirme/izlem girişimleri:** "Bireyin kan basıncı her izlemde doğru teknikle iki kez ölçülüp kaydedilecek." "Annenin bir emzirmesi baştan sona gözlenecek."
2. **Eğitim/danışmanlık girişimleri:** "Bireye gizli tuz içeren besinler resimli kartla anlatılacak." "Anneye doğru tutuş ve kavrama maket bebek üzerinde gösterilip kendisine uygulatılacak."
3. **Terapötik/destekleyici girişimler:** "Emzirme sırasında kavrama düzeltilecek." "Bireyin duygularını ifade etmesi için zaman ayrılacak."
4. **Yönlendirme ve koordinasyon girişimleri:** "Birey diyetisyene yönlendirilecek." "Polifarmasi açısından hekime bilgi verilecek."

Bir girişim nasıl yazılır? Eylem fiili + ne + nasıl + ne zaman/ne sıklıkla. Örneğin "Eğitim verilecek" yerine "**Bireye ve yemekleri hazırlayan eşine, günlük tuz sınırı ve gizli tuz kaynakları, 5 gram tuzun çay kaşığıyla gösterilmesi ve resimli broşür kullanılarak, ilk görüşmede 15 dakikalık bir eğitimle anlatılacak.**"

Gerekçe: Her girişimin yanına **neden** yapıldığı kısaca yazılır (bilimsel dayanak). Örneğin: "Tuz kısıtlaması kan basıncını düşürür; yemekleri hazırlayan aile üyesinin eğitime katılması davranış değişikliğini kolaylaştırır." Gerekçe, girişimin bilinçli seçildiğini gösterir ve formdaki "bireye özgü girişim" puanını artırır.

Girişimleri bireye özgüleştirmek (FR.185 madde 17): Kitaptaki standart girişim listesini kopyalamak yerine bireyin özelliklerine göre uyarla:

- **Yaş:** Yaşlıya büyük puntolu, yavaş, tekrarlı eğitim; ergene tartışma ve öz kararı destekleyen yaklaşım.
- **Okuryazarlık ve eğitim düzeyi:** Okuma yazma bilmeyen bireye resimli ilaç takvimi, sesli anlatım, gösterip yaptırma.
- **Kültür ve inançlar:** Lohusalık geleneklerine saygı gösterip zararlı olanları (bebeğe şekerli su, göbeğe madde sürme) nazikçe düzeltme; oruç tutan diyabetliyle ilaç saatlerini hekimle planlama.

- **Ekonomik durum:** Pahalı ürünler yerine ulaşılabilir seçenekler; ücretsiz hizmetlere (KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezi) yönlendirme.
- **Aile ve sosyal destek:** Yemekleri kim yapıyor, bebeğe kim bakıyor, yaşlının yanında kim var? Bu kişiler plana dahil edilir.
- **Bireyin tercihleri ve hazır oluşu:** Birey hangi davranışı değiştirmeye hazır? (Transteorik modele göre düşünmeme aşamasındaki sigara içicisine bırakma tarihi değil, farkındalık girişimi planlanır.)
- **Güçlü yönler:** Öğrenmeye istekli, okuryazar, eşi destekleyici gibi özellikler girişimlerde kullanılır.

---

5. UYGULAMA

Formda "**girişimleri öncelik sırasına göre uygulayabilme**" (4 puan) olarak geçer.

- Uygulamaya geçmeden önce birey yeniden değerlendirilir; durum değişmişse (örneğin kan basıncı çok yükselmişse) önce o ele alınır.
- Girişimler **öncelikli tanıdan başlanarak** ve her tanı içinde mantıklı bir sırayla uygulanır: önce değerlendirme, sonra terapötik girişim, sonra eğitim, sonra yönlendirme ve izlem planı.
- Bireyin **onayı** alınır, girişimler bireyle **birlikte** yapılır.
- Her girişim **kaydedilir**: ne yapıldı, ne zaman, nasıl ve **bireyin yanıtı** neydi. Örneğin: "10.30 – Bireye ve eşine tuz kısıtlaması eğitimi verildi (15 dk, resimli kart ve çay kaşığı ile gösterim). Birey gizli tuz içeren 5 besini doğru saydı; 'Turşuyu bırakmak zor olacak' dedi."
- Uygulama sırasında elde edilen yeni veriler, değerlendirme ve yeniden planlamada kullanılır.

---

6. DEĞERLENDİRME VE YENİDEN PLANLAMA

Formda iki ölçütle puanlanır: **sonuç kriterlerine göre değerlendirme** (4) ve **değerlendirme sonucuna göre süreci yeniden planlama** (4).

6.1 Sonuç kriterlerine göre değerlendirme

Her sonuç kriteri **tek tek** ele alınır ve üç karardan biri verilir:

- **Ulaşıldı:** Kriterde belirtilen davranış ya da durum gerçekleşti.
- **Kısmen ulaşıldı:** Bir kısmı gerçekleşti.
- **Ulaşılmadı:** Gerçekleşmedi.

Her kararın yanına **kanıtı** yazılır (ölçüm, gözlem, bireyin ifadesi, test puanı). "Amaca ulaşıldı" demek tek başına yeterli değildir.

Örnek değerlendirme cümleleri:

- "Kriter 1: Ulaşıldı. Birey eğitimin sonunda inme, kalp krizi ve böbrek yetmezliğini kontrolsüz hipertansiyonun komplikasyonları olarak saydı."
- "Kriter 3: Kısmen ulaşıldı. İlaç kutusuna göre birey 14 günün 11'inde ilacını almıştı (hedef 13 gündü)."
- "Kriter 4: Ulaşılmadı. Bir ay sonraki izlemde iki ölçümün ortalaması 146/92 mmHg bulundu."

6.2 Neden ulaşılamadı? – Yeniden değerlendirme soruları

Kriter kısmen ya da hiç karşılanmadıysa süreç geriye doğru gözden geçirilir:

- **Veri toplama:** Eksik ya da yanlış veri var mıydı? Bireyin gerçek engeli neydi?
- **Tanı:** Tanı ve etiyoloji doğru muydu? Örneğin ilacı bırakmanın nedeni bilgi eksikliği değil, ilacın yan etkisi olabilir.
- **Sonuç kriteri:** Gerçekçi miydi? Süre yeterli miydi?
- **Girişimler:** Bireye uygun muydu? Yeterli sıklıkta yapıldı mı? Aile katıldı mı?
- **Birey:** Davranışı değiştirmeye hazır mıydı? Yeni bir sorun ortaya çıktı mı?

6.3 Yeniden planlama kararları

Değerlendirmenin sonunda dört karardan biri verilir ve **yazılı olarak** belirtilir:

1. **Planı sürdür:** Kriterlere ulaşılıyor ama süre gerekiyor (ör. kilo kaybı devam ediyor).
2. **Planı revize et:** Yeni girişimler, değiştirilmiş kriterler ya da yeni süre belirle. Örneğin: "İlaç atlamanın nedeni sabahları aceleyle unutmak olarak belirlendi; ilacın kahvaltı masasında tutulması ve eşinin hatırlatması planlandı. Kan basıncı değerleri hekimle paylaşıldı. İki hafta sonra yeniden izlem."
3. **Tanıyı sonlandır:** Tüm kriterlere ulaşıldı, sorun çözüldü. Örneğin: "15. gün izleminde bebek doğum ağırlığına ulaştı, meme başı çatlakları iyileşti, anne mama takviyesini bıraktı; Etkisiz emzirme tanısı çözüldü. Annenin isteği doğrultusunda 'Emzirmeyi geliştirmeye hazır oluş' tanısıyla destek sürdürülecek."
4. **Yeni tanı ekle:** Değerlendirmede yeni bir sorun ortaya çıktıysa.

Formdaki 20. madde tam olarak bunu ister; **değerlendirme yapıp yeniden planlama bölümünü boş bırakmak** 4 puanın kaybı demektir.

---

7. TAM ÖRNEK BAKIM PLANLARI

7.1 Örnek A – ASM: Hipertansiyonu olan erişkin

Bireyi tanıtan bilgiler ve veriler M.K., 58 yaşında, erkek, evli, emekli, ilkokul mezunu. Eşiyle yaşıyor; iki çocuğu ayrı evde. Veriler bireyin kendisinden, eşinden, ASM kayıtlarından, ölçüm ve gözlemden toplandı.

- *Sağlığı algılama-sağlık yönetimi:* 3 yıldır hipertansiyon tanısı var; amlodipin 5 mg reçete edilmiş. "Kendimi iyi hissedince ilacımı içmiyorum." "Tansiyon zaten herkeste var." İlaç kutusunda son 2 haftada alınması gereken 14 tabletten 9'unun durduğu görüldü. Günde 1 paket sigara içiyor (30 yıldır). Son 2 yıldır kolorektal kanser taraması yapılmamış.
- *Beslenme-metabolik:* Boy 1,70 m, kilo 85 kg, BKİ 29,4, bel çevresi 104 cm. Yemeklere tadına bakmadan tuz ekliyor, her öğünde turşu yiyor, günde yarım ekmek tüketiyor. "Tuzsuz yemek boğazımdan geçmiyor." Yemekleri eşi hazırlıyor.
- *Aktivite-egzersiz:* Haftada 1 gün 20 dakika yürüyor; günün çoğunu kahvede ve televizyon karşısında geçiriyor. KB: sağ kol 156/96, sol kol 152/94 mmHg (iki ölçüm ortalaması 154/95). Nabız 82/dk, düzenli.
- *Bilişsel-algısal:* Okuryazar; gözlük kullanıyor; zaman zaman ense ağrısı.
- *Rol-ilişki:* Eşiyle ilişkisi iyi, eşi destekleyici ve eğitime katılmaya istekli.
- *Güçlü yönler:* Eşinin desteği, okuryazar olması, kontrollere gelmesi.

Tanılar ve öncelik sırası

1. Etkisiz sağlık yönetimi (en öncelikli: kan basıncı kontrol dışı ve ilaç uyumu yetersiz; çözülmesi komplikasyon riskini doğrudan azaltır)
2. Riskli sağlık davranışı – sigara kullanımı
3. Sedanter yaşam biçimi

Tanı 1: Etkisiz sağlık yönetimi; tedavi rejimine ve hastalığın olası sonuçlarına ilişkin bilgi eksikliği ile ilişkili; antihipertansif ilacını kendini iyi hissettiğinde bırakması, son iki haftada 14 tabletin 9'unu almamış olması, "Tansiyon zaten herkeste var" demesi, yemeklerine tadına bakmadan tuz eklemesi ve kan basıncının 154/95 mmHg olması ile kendini gösteren.

Amaç: Bireyin hipertansiyon yönetimi etkili hale gelecek.

Sonuç kriterleri:

1. Birey eğitimin sonunda kontrol edilmeyen hipertansiyonun en az üç komplikasyonunu sayacak.
2. Birey eğitimin sonunda günlük tuz sınırını (5 g'ın altı) ve gizli tuz içeren en az beş besini ifade edecek.
3. Birey iki hafta sonraki izlemde, ilaç kutusunu göstererek 14 günün en az 13'ünde ilacını aldığını gösterecek.
4. Bireyin bir ay sonraki izlemde ofis kan basıncı ortalaması 140/90 mmHg'nin altında olacak.

Girişimler ve gerekçeleri:

1. Bireyin hipertansiyonla ilgili bilgi ve inançları açık uçlu sorularla değerlendirilecek. *Gerekçe: Sağlık İnanç Modeline göre bireyin hastalığın ciddiyetini ve kendi duyarlılığını algılaması tedaviye uyumu belirler; eğitim bireyin mevcut inançlarından başlamalıdır.*
2. Hipertansiyonun çoğunlukla belirti vermeden ilerlediği ve kalp, beyin, böbrek ve gözlerde yol açabileceği hasar, resimli kart kullanılarak anlatılacak. *Gerekçe: "Belirti yoksa hastalık yok" inancı ilaç bırakmanın en sık nedenidir.*

3. İlacın her gün aynı saatte, kendini iyi hissetse de bırakılmadan alınması gerektiği açıklanacak; haftalık ilaç kutusu ve telefon alarmı önerilecek; ilk haftanın ilaç kutusu birlikte doldurulacak. *Gerekçe: Hatırlatıcı yöntemler ilaç uyumunu artırır.*
4. Bireye ve yemekleri hazırlayan eşine günlük tuz sınırı (yaklaşık bir silme çay kaşığı), gizli tuz kaynakları (ekmek, turşu, peynir, salamura, hazır çorba), tuzluğun sofradan kaldırılması ve limon-baharatla lezzetlendirme, 5 gram tuz çay kaşığıyla gösterilerek anlatılacak. *Gerekçe: Tuz kısıtlaması kan basıncını düşürür; yemekleri hazırlayan aile üyesinin katılımı davranış değişikliğini kolaylaştırır.*
5. Bireye evde doğru kan basıncı ölçümü ve ölçüm günlüğü tutması öğretilecek; ölçümü hemşirenin yanında yapması istenecek. *Gerekçe: Öz izlem bireyin hastalığını yönetmeye katılımını artırır.*
6. Kan basıncının çok yükseldiği durumlarda acil belirtiler (şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, görme ve konuşma bozukluğu, kolda güçsüzlük) ve 112 anlatılacak.
7. Bireyin değerleri ve ilaç uyumu hakkında hekime bilgi verilecek; birey Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyenine yönlendirilecek. *(İşbirlikçi girişim)*
8. İki hafta sonra izlem randevusu verilecek.

Uygulama: Girişimler ilk görüşmede 1–6 sırasıyla uygulandı (yaklaşık 30 dakika); eşi görüşmeye katıldı. Birey eğitim sırasında "Turşuyu bırakmak zor olacak ama azaltırım" dedi; evde ölçümü doğru basamaklarla yaptı. Hekime bilgi verildi, diyetisyen randevusu alındı.

Değerlendirme:

- Kriter 1: Ulaşıldı – inme, kalp krizi ve böbrek yetmezliğini saydı.
- Kriter 2: Ulaşıldı – tuz sınırını söyledi, ekmek, turşu, peynir, salamura ve hazır çorbayı saydı.
- Kriter 3: Kısmen ulaşıldı – iki hafta sonra ilaç kutusuna göre 14 günün 11'inde ilacını almış.
- Kriter 4: Ulaşılmadı – bir ay sonra KB ortalaması 146/92 mmHg.

Yeniden planlama: İlaç atlamanın nedeni sorgulandı; birey "Sabah kahvaltı etmeden çıkınca unutuyorum" dedi. İlacın kahvaltı masasında tutulması ve eşinin hatırlatması planlandı. Ev ölçüm günlüğü ve ofis değerleri hekimle paylaşıldı (tedavi düzenlemesi hekim kararıdır). Tuz tüketimini azaltmaya başladığı, turşuyu günde bire indirdiği öğrenildi; bu olumlu davranış pekiştirildi. İki hafta sonra yeniden izlem planlandı; kriter 3 ve 4 aynı biçimde yeniden değerlendirilecek.

Tanı 2: Riskli sağlık davranışı (sigara kullanımı); sigaranın zararlarını hafife alma ve bırakmaya ilişkin motivasyon eksikliği ile ilişkili; 30 yıldır günde 1 paket sigara içmesi ve "Bu yaştan sonra bırakmanın faydası yok" demesi ile kendini gösteren. *Amaç:* Birey sigarayı bırakmaya yönelik adım atacak. *Sonuç kriterleri:* Birey görüşme sonunda sigarayı bırakmanın kendisi için en az iki yararını ifade edecek; bir ay içinde sigara bırakma danışma hattını (ALO 171) arayacak ya da bırakma polikliniğine randevu alacak. *Girişimler:* Bireyin bırakmaya hazır oluşu değerlendirilecek (düşünmeme aşamasında olduğu belirlendi); her yaşta bırakmanın yararları kısa ve kişisel mesajlarla anlatılacak (KB ve kalp riskindeki azalma, torunlarıyla daha uzun zaman); yargılamadan, bireyin kendi gerekçelerini bulmasına yardım eden motivasyonel görüşme yapılacak; ALO 171 ve bırakma polikliniği bilgisi verilecek; her izlemde konu yeniden açılacak. *Gerekçe: Davranış değişikliği aşamalı bir süreçtir; düşünmeme aşamasındaki bireyde amaç farkındalık oluşturmak ve bir sonraki aşamaya geçişi sağlamaktır. Değerlendirme (örnek):* Birey iki yararı ifade etti (ulaşıldı); bir ay sonra ALO 171'i aramamış ama günlük sigarayı 15'e indirdiğini söyledi (kısmen ulaşıldı) → plan sürdürülecek, düşünme aşamasına geçtiği değerlendirildi, bırakma tarihi belirlemesi için destek verilecek.

Tanı 3: Sedanter yaşam biçimi; fiziksel aktivitenin yararlarına ilişkin bilgi eksikliği ve alışkanlıklar ile ilişkili; haftada yalnızca 20 dakika yürüyüş yapması, günün çoğunu oturarak geçirmesi ve bel çevresinin 104 cm olması ile kendini gösteren. *Amaç:* Birey düzenli fiziksel aktivite yapacak. *Sonuç kriterleri:* Birey eğitimin sonunda yetişkinler için önerilen

haftalık fiziksel aktivite süresini (en az 150 dakika) ifade edecek; bir ay sonraki izlemde haftada en az 5 gün 30 dakika yürüdüğünü yürüyüş günlüğüyle gösterecek. *Girişimler:* Yürüyüşün kan basıncı ve kilo üzerindeki etkisi anlatılacak; bireyin sevdiği ve ulaşabileceği bir etkinlik birlikte seçilecek (eşiyle akşam yürüyüşü); süre kademeli artırılacak (ilk hafta 15 dakika, her hafta 5 dakika artış); yürüyüş günlüğü verilecek.

7.2 Örnek B – Lohusa izlemi: Etkisiz emzirme

Veriler: Z.T., 24 yaşında, ilk doğumu, normal doğum, doğum sonu 6. gün, ev ziyareti. "Emzirirken çok canım yanıyor." "Sütüm yetmiyor, iki gündür mama ekliyorum." İki meme başında çatlak. Emzirme gözleminde bebeğin yalnızca meme başını kavradığı, alt dudağının içe döndüğü, yanaklarının çukurlaştığı görüldü. Bebek doğum ağırlığının %8'ini kaybetmiş; günde 5 ıslak bez. Eşi ve kayınvalidesi evde; kayınvalidesi "Sütün yetmiyor, mama ver" diyor. Güçlü yönler: Emzirmek istiyor ("Bebeğimi kendi sütümle büyütmek istiyorum"), eşi destekleyici.

Tanı: Etkisiz emzirme; emzirme tekniğine (tutuş ve kavrama) ilişkin bilgi ve beceri eksikliği ve aileden gelen mama önerisi ile ilişkili; meme başlarında çatlak ve ağrı, bebeğin yalnızca meme başını kavraması, annenin mama takviyesi yapması, "Sütüm yetmiyor" demesi ve bebeğin doğum ağırlığının %8'ini kaybetmiş olması ile kendini gösteren.

Amaç: Anne bebeğini etkili biçimde emzirecek.

Sonuç kriterleri:

1. Anne görüşme sırasında doğru tutuş ve kavramanın dört belirtisinin gözlendiği bir emzirme yapacak.
2. Anne görüşme sonunda bebeğin yeterli süt aldığını gösteren en az üç belirtiyi ifade edecek.
3. Anne 15. gün izleminde mama takviyesini bıraktığını ve günde en az 8 kez emzirdiğini ifade edecek.
4. Bebek 15. gün izleminde doğum ağırlığına ulaşmış olacak.
5. 15. gün izleminde meme başı çatlakları iyileşmiş olacak.

Girişimler ve gerekçeleri:

1. Bir emzirme baştan sona gözlenecek. *Gerekçe: Sorunun kaynağı (çoğunlukla yanlış kavrama) ancak gözlemle anlaşılır.*
2. Doğru tutuş ve kavrama anlatılıp gösterilecek, annenin emzirmesi sırasında elle destek verilerek düzeltilecek; bebeği memeden ayırırken serçe parmağını ağız kenarından sokması öğretilecek. *Gerekçe: Doğru kavrama hem meme başı yaralanmasını önler hem süt aktarımını artırır.*
3. Emzirmeye daha az ağrıyan memeden başlaması, emzirme sonrası birkaç damla sütü meme başına sürüp kurutması, meme başını sabunla yıkamaması önerilecek. *Gerekçe: Anne sütü meme başı iyileşmesini destekler; sabun cildi kurutur.*
4. Süt yapımının "arz-talep" ilkesiyle çalıştığı, sık emzirmenin süt miktarını artırdığı, mama ve biberonun süt üretimini azaltabileceği anne ve kayınvalidesine birlikte anlatılacak. *Gerekçe: Aile büyüklerinin inanç ve önerileri emzirmeyi etkiler; aileyi sürece katmak çatışmayı azaltır.*
5. Yeterli süt belirtileri (günde 6 ve üzeri ıslak bez, sarı yumuşak dışkı, emzirme sonrası rahatlama, kilo alımı) anlatılacak.
6. Mama takviyesinin aşamalı olarak bırakılması planlanacak; bebeğin ağırlığı 3 gün sonra kontrol edilecek. Bebeğin kilo kaybı hekime bildirilecek.
7. Gerekirse emzirme danışmanına yönlendirilecek; 15. gün izlemi planlanacak.

Değerlendirme: Kriter 1 ve 2 görüşmede ulaşıldı. 3 gün sonraki kontrolde bebek 70 g almıştı. 15. gün izleminde anne mamayı bıraktığını ve günde 9–10 kez emzirdiğini söyledi (ulaşıldı), bebek doğum ağırlığının 60 g üzerindeydi (ulaşıldı), çatlaklar iyileşmişti (ulaşıldı).

Yeniden planlama: Tüm kriterlere ulaşıldığı için "Etkisiz emzirme" tanısı sonlandırıldı. Anne ilk 6 ay yalnızca anne sütü vermek istediğini ifade ettiği için "**Emzirmeyi geliştirmeye hazır oluş**" tanısıyla destek sürdürülecek; 41. gün izleminde emzirme yeniden değerlendirilecek.

7.3 Örnek C – Ev ziyareti: Yaşlıda düşme riski

Veriler: H.D., 78 yaşında, kadın, dul, yalnız yaşıyor; kızı haftada bir ziyaret ediyor. Hipertansiyon, diz osteoartriti ve uykusuzluk nedeniyle toplam 6 ilaç kullanıyor (biri uyku ilacı). Son 6 ayda bir kez gece tuvalete giderken düşmüş. "Gece kalkınca başım dönüyor." "Yine düşerim diye korkuyorum, dışarı çıkmıyorum." Kalk ve Yürü testi 16 saniye; yürürken mobilyalara tutunuyor. Oturur KB 138/82, ayağa kalktıktan 3 dakika sonra 116/74 mmHg. Evde kaygan halılar var, yatak odası ile tuvalet arasındaki koridorda aydınlatma yok, banyoda tutunma barı yok. Güçlü yönler: Bilişsel durumu iyi, telefonu kullanabiliyor, kızı yardıma istekli.

Tanılar ve öncelik: 1) Düşme riski (güvenlik; ciddi yaralanma riski), 2) Sosyal izolasyon riski / düşme korkusuna bağlı aktivite kısıtlılığı.

Tanı 1: Düşme riski; son 6 ayda düşme öyküsü, ortostatik hipotansiyon, Kalk ve Yürü testinin 16 saniye olması, uyku ilacı dahil 6 ilaç kullanımı, evde kaygan halılar, koridorda aydınlatma ve banyoda tutunma barı olmaması ve yalnız yaşama ile ilişkili.

Amaç: Birey düşmeyecek; düşme riski azalacak.

Sonuç kriterleri:

1. Birey görüşme sonunda evinde düşmeye neden olabilecek en az dört tehlikeyi ve önlemini ifade edecek.
2. Birey görüşme sırasında yataktan güvenli kalkma basamaklarını (oturup 1–2 dakika bekleme, sonra destekle kalkma) gösterecek.
3. İki hafta sonraki ev ziyaretinde kaygan halılar kaldırılmış, yatak odası ile tuvalet arasına gece lambası konmuş olacak.
4. İlaçları bir ay içinde hekim tarafından gözden geçirilmiş olacak.
5. Birey üç ay boyunca düşme yaşamayacak.

Girişimler ve gerekçeleri:

1. Ev güvenliği kontrol listesiyle evin her odası birlikte değerlendirilecek; tehlikeler ve önlemleri bireye ve kızına gösterilecek. *Gerekçe: Çevresel tehlikelerin giderilmesi yaşlılarda düşmeleri azaltır.*
2. Ortostatik hipotansiyonun anlamı açıklanacak; yataktan kalkarken önce oturup bacaklarını sarkıtması, 1–2 dakika beklemesi, sonra tutunarak kalkması öğretilip uygulatılacak.
3. Gece tuvalet yoluna gece lambası, banyoya tutunma barı ve kaydırmaz paspas konması, halıların kaldırılması kızıyla birlikte planlanacak.
4. İlaç listesi çıkarılıp (ilaç poşeti yöntemiyle) polifarmasi ve uyku ilacı kullanımı açısından hekime bildirilecek. *Gerekçe: Sedatif ve tansiyon düşürücü ilaçlar düşme riskini artırır; ilaçların gözden geçirilmesi hekim kararıdır.*
5. Basit denge ve kuvvet egzersizleri (sandalyeye tutunarak parmak ucunda yükselme, oturup kalkma) gösterilip uygulatılacak; her gün yapması önerilecek.
6. Kaymaz tabanlı, arkası kapalı terlik giymesi, gözlüğünü gece de yakında tutması önerilecek.
7. Telefonun yanında taşınması, kızıyla ya da komşusuyla günlük iletişim planı yapılacak; düştüğünde nasıl yardım isteyeceği konuşulacak.
8. İki hafta sonra ev ziyareti planlanacak.

Değerlendirme (iki hafta sonra): Kriter 1 ve 2 ilk ziyarette ulaşıldı. Halılar kaldırılmış (ulaşıldı), ancak gece lambası ve tutunma barı alınamamış (kısmen) – nedeni maddi olanaksızlık ve montaj yapacak kişinin olmaması. Hekim ilaçları gözden geçirmiş, uyku ilacının dozunu azaltmış (ulaşıldı). Düşme olmamış.

Yeniden planlama: Maddi engel nedeniyle belediye sosyal hizmetleri ve yaşlı destek birimlerine yönlendirme yapıldı; kızı ve komşusuyla gece lambası takılması planlandı. Kriter 5'in değerlendirilmesi için üç ay boyunca aylık telefon görüşmesi ve bir ev ziyareti planlandı.

7.4 Örnek D – Sağlığı geliştirme tanısı: Gebe

Veriler: S.A., 27 yaşında, 14 haftalık ilk gebeliği. Kronik hastalığı yok, BKİ 22. "Gebelikte nelere dikkat etmem gerektiğini öğrenmek istiyorum." "İnternette çok farklı şeyler okuyorum, kafam karıştı." Folik asit kullanıyor; D vitamini ve demirin ne zaman başlayacağını bilmiyor. Okuryazar, lise mezunu, eşi destekleyici.

Tanı: Bilgiyi geliştirmeye hazır oluş (gebelikte öz bakım); "Gebelikte nelere dikkat etmem gerektiğini öğrenmek istiyorum" demesi, beslenme ve destekler hakkında sorular sorması ve "Kafam karıştı" diyerek güvenilir bilgi araması ile kendini gösteren.

Amaç: Gebe, gebelikte öz bakımına ilişkin güvenilir bilgiye sahip olacak ve bunu uygulayacak.

Sonuç kriterleri: Gebe eğitimin sonunda D vitamini ve demirin ne zaman başlayacağını ve nasıl kullanılacağını ifade edecek; gebelikte kaçınması gereken en az beş besin/davranışı sayacak; gebelikteki tehlike belirtilerinden en az altısını sayacak; bir sonraki izlemde D vitamini ve demiri doğru kullandığını ifade edecek.

Girişimler: Bireyin bilgi düzeyi ve kaygıları belirlenecek; beslenme, kaçınılacaklar, destekler, tehlike belirtileri ve izlem takvimi tek tek anlatılacak; güvenilir bilgi kaynakları ve gebe okulu önerilecek; eşin de bir sonraki görüşmeye katılması teşvik edilecek; yazılı broşür verilecek.

---

8. BAKIM PLANI YAZARKEN KONTROL LİSTESİ

Bakım planını teslim etmeden önce şu soruları kendine sor:

- Veri kaynaklarını belirttim mi? Hem subjektif (tırnak içinde) hem objektif veri var mı?
- Verileri bir model (Gordon, Omaha) çerçevesinde, hiçbir alanı atlamadan topladım mı?
- Bireyin güçlü yönlerini yazdım mı?
- Tanılar NANDA-I etiketleriyle mi yazıldı? Tıbbi tanı kullanmadım değil mi?
- Tanıları öncelik sırasına koyup gerekçesini yazdım mı? 3–5 tanı var mı?
- Her problem odaklı tanıda **etiyoloji** ("... ile ilişkili") ve **tanımlayıcı özellikler** ("... ile kendini gösteren") var mı?
- Risk tanılarında risk faktörlerini, sağlığı geliştirme tanılarında istek ifadesini yazdım mı?
- Amaç bireye ait ve tanının problem kısmına yönelik mi?
- Her sonuç kriterinde özne, ölçülebilir fiil, ölçüt ve zaman var mı? "Öğrenir, bilir, anlar" kullanmadım değil mi?
- Girişimler etiyolojiye yönelik mi? Bireyin yaşı, okuryazarlığı, kültürü, ailesi dikkate alındı mı? Her girişimin gerekçesi var mı?
- Uygulamada ne yaptığımı, ne zaman yaptığımı ve bireyin yanıtını kaydettim mi?
- Her sonuç kriterini kanıtıyla değerlendirdim mi?
- Ulaşılamayan kriterler için nedeni analiz edip yeniden planlama yaptım mı? Planı sürdürme/revize etme/sonlandırma kararını yazdım mı?

---

9. KENDİNİ TEST ET

1. Hemşirelik sürecinin beş basamağı nedir? FR.185'te hangi basamak kaç puandır?
2. Subjektif ve objektif veriye ikişer örnek ver. Subjektif veri bakım planında nasıl yazılır?
3. Birincil ve ikincil veri kaynakları nelerdir?
4. "Bütüncül ve sistematik veri toplama" ne demektir? Gordon'un 11 fonksiyonel sağlık örüntüsünü say.
5. Duvall'ın aile yaşam döngüsünün evrelerini say. İkinci evrenin gelişimsel görevleri nelerdir?
6. Hemşirelik tanısı ile tıbbi tanı arasındaki fark nedir? Bir örnekle açıkla.
7. NANDA-I tanısının bileşenleri nelerdir?
8. Problem odaklı, risk ve sağlığı geliştirme tanılarının yazım biçimlerini birer örnekle göster.
9. "Hipertansiyon ile ilişkili etkisiz sağlık yönetimi" ifadesindeki hata nedir? Doğrusunu yaz.
10. Etiyoloji yazarken uyulması gereken kurallar nelerdir?
11. Risk tanısında neden tanımlayıcı özellik yazılmaz?
12. Tanıları önceliklendirirken hangi ölçütleri kullanırsın?
13. Amaç ile sonuç kriteri arasındaki fark nedir?
14. Bir sonuç kriterinin beş öğesi nedir? "Hasta diyabet hakkında bilgi sahibi olacak" kriterini SMART biçimde yeniden yaz.
15. Bağımsız, bağımlı ve işbirlikçi girişimlere birer örnek ver.
16. Bir girişimi bireye özgüleştirmek için hangi özellikleri dikkate alırsın?
17. Uygulama aşamasında kayıt nasıl yapılır?
18. Değerlendirmede "kısmen ulaşıldı" kararı verdiğinde neleri gözden geçirirsin?
19. Yeniden planlamada hangi kararlar verilebilir? Her birine örnek ver.